自立支援医療（精神通院医療）について

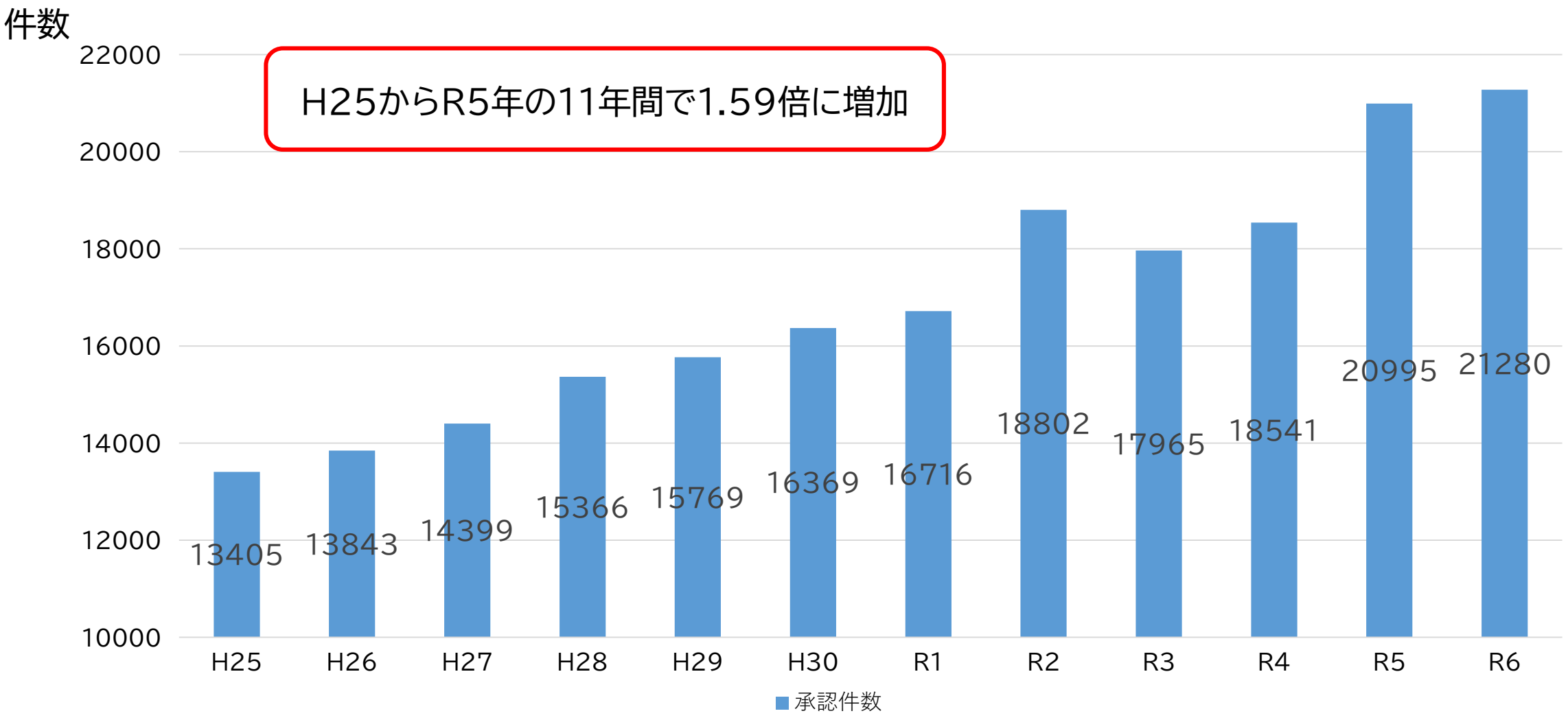
令和7年8月12日改訂版

野口正行
岡山県精神保健福祉センター

はじめに

- 自立支援医療（精神通院医療）は、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対し、精神科通院に関する支給を受けることで、必要な精神科外来・訪問医療の継続が促進される点で大切な制度
- その一方で、公費の投入もされており、制度の持続可能性の確保のためにも適正な制度利用が求められる
- 的確な審査が行われるためにも、適切な申請と診断書記入が求められる

自立支援医療（精神通院医療）の承認件数の推移



自立支援医療（精神通院医療）

以下は、次の通知に基づいて岡山県の審査委員会で合意されたものを記載しています。

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による精神障害者通院医療費公費負担制度の運用について」
H14.5.21障精発0521001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知

「自立支援医療費の支給認定について」
H18.3.3障発0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。H26.1.24障発0124第6号最近改正

自立支援医療（精神通院医療）

- 対象
  - 精神障害者またはてんかんを有する者で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態のもの
- 範囲
  - 入院していないで行われる医療（外来あるいは訪問）
  - 当該精神障害の症状に起因して生じた病態と当該精神障害の治療に関連して生じた病態（薬物療法の副作用等）
  - 精神障害により、自己の安全や健康を守る能力が著しく低下していると判断される場合には、身体疾患も対象になる。

自立支援医療（精神通院医療）の対象

- 自立支援医療（精神通院医療）は、精神障害の状態や情動及び行動の障害等が精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、あるいは消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とする場合に対象となります。
- 上記から、薬物療法を行っておらず、かつ、通院頻度も少ない場合は、精神病、あるいはそれと同等の病態とは認められずに、非該当の判定となる場合があります。
- こうした場合は、疑義照会（返戻）により、その理由等を確認し、薬物療法を行わず通院頻度が少ない理由等がやむを得ないものと認められる場合は、対象となります。

診断書の記載の留意点

- 症状がほとんど消失していても、その状態を維持したり、再発を予防するための治療継続は対象→このことがわかる記載が必要
- うつ状態、不安状態は「入院を要するか、入院を要しない場合も精神病水準」の重症度を想定している→重症度もわかる記載が必要
- 知的障害や認知症は、易怒性、気分変動、暴力、衝動行為、食行動異常等の行動の障害を伴い、継続的な治療が必要な場合→知的障害や認知症のみでは対象にならない
- 器質性精神障害の原因疾患の検査・治療などは対象にはならない→例：二次性てんかんの原因の脳腫瘍の精査などは対象外
- 通院医療機関とデイケアの医療機関と分ける場合などには、その必要性について記載する。基本は一つの医療機関が対象

①②診断、経過や症状の記載の留意点

- **①「病名」の「主たる精神障害」**
  - 疑い病名ではなく、ICDなど診断基準に準拠した確定診断名で書いてください。
  - 「適応障害」は原則6か月までの持続期間の病状に対して用いられますので、それ以上に長期の治療が必要な場合には、診断名の変更を検討ください。
- **②「発病から現在までの経過」、**
  - ②では、上記の診断を行った根拠を審査委員が判断できるように症状と経過を書いてください。
  - ②では、どれくらいの治療を行っているかが分かるように、最近1年間の診察の頻度など（2週間に1回など）も書いてください。
  - ③④も含めて、診断が妥当であることが審査委員に判断できるように、診断の根拠となる症状を、必要に応じて具体的なエピソードや発言なども含めて記載してください。

③「現在の病状、状態像等」
④「病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」

- 症状についての記載では、「抑うつ、不安、不眠」などの用語の羅列ではなく、病状が一定程度の重症度があり、継続した治療が必要であることが判断できるように、適宜具体的なエピソードや発言を入れながら書いてください。
- 更新申請で症状が落ち着いている場合、継続した治療が必要であることがわかるように、治療を中止した場合に出現が予想される状態も書いてください。
- 認知症の場合、認知症の程度が推測できるように、長谷川式簡易知能評価スケールなどの検査結果も書いてください。ただし、検査結果の羅列ではなく、状態が分かるように、症状を具体的に記載してください。

⑤⑥治療や治療方針の記載

- **⑤「現在の治療内容」の1「投薬内容」**
  - 使用している薬剤の名前と用量が分かるように書いてください。
- **2「精神療法等」**
  - 行っている精神療法の内容がわかるように具体的に書いてください。(例:「認知行動療法を行っている」、「本人の不安を傾聴し支持的精神療法を行っている」等)
  - てんかんでは、精神療法の項目では、疾病教育、服薬指導、その他の環境調整なども含めて記載してください。
  - 認知症では、本人のBPSD等の改善に役立つ本人への対応や家族への教育なども含めて記載してください。
- **⑥「今後の治療方針」**
  - ①治療の目標、②それを達成するための方法をそれぞれわかるように記載してください。

コメントや返戻の例

自立支援医療の診断書でお願いしたいこと

- 特に新規申請では、発病状況からその後の治療経過を書いていただき、継続した精神科治療が必要であることが分かるように書いてください。
- 継続申請の場合、前回診断書記載時からの経過を書いてください。
- 認知症や知的能力障害では、それらに加えて継続した精神科的治療が必要な状態が認定には必要です。
- 個別性に配慮した具体的な治療内容の記載を書いてください。
- ⑥の「治療方針」では、「治療の目標」と「それを達成するための方法」を両方わかるように具体的に書いてください。

返戻の対象になる場合

- 以下の場合には、継続的な精神科的治療が必要な精神疾患であることが判断できないため、返戻の対象となります。
- 「①主たる精神障害」に書かれている病名について、「②発病から現在までの経過」に、発病状況、受診時の症状、その後の治療経過、特に最近1～2年間の治療経過が記載されていない。
- 認知症や知的能力障害で、それらの障害に加えて継続的な精神科的治療を要する症状が書かれていない。
- ③④の精神症状が「落ち着いている」だけで、具体的な症状が書かれていない。
- ⑤-2に「精神療法」のみ書かれており、具体的な内容が書かれていない。
- ⑥に「通院の継続」「上記の通り」など具体的な記載がない。

よくある記載例　1

②「発病から現在までの経過」、

③④「病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」

- 経過は「抑うつが認められた。K-6が〇〇点でカットオフ値を超えるので、うつ病と診断した。」と記載。
- 症状は「抑うつ、意欲低下、食欲低下、自己評価の低下」と記載。

→症状が羅列されているが、全体像や重症度も記載からよくわからない

→尺度は診断の参考にはなるが、それで診断確定することはできない。

□うつ病と診断する根拠について、審査委員が判断できる症状や経過を記載する

□診断については、尺度や症状を羅列したり、診断基準に機械的に当てはめるのではなく、症状や経過の全体像が分かるように、場合によっては具体的な発言や状況描写も含めて記載する。

よくある記載例　2

②「発病から現在までの経過」

- 「現在は月に1回通院している」

→発病からどのような治療をしてどういう経過を辿って今に至ったのか？

□発病時の状況や症状、その後の治療経過、最近1、2年間の状態と治療状況などを、簡潔に記載をする（特に新規申請の場合）

③④「病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見等」

- 「今は落ち着いている」

→治療継続が必要な状況があるのか？治療しないとどうなるか？

□例）治療継続の必要性を書くことが必要なので、治療をしない場合などに状態悪化して予測される症状などを書く。

よくある記載例　3

⑤(2)「精神療法等」

- 「通院精神療法」

→精神療法として何をしているのか？

□例)職場の同僚との対人トラブルからうつを繰り返す人には、「対人関係の状況を振り返り、対応方法について検討する」など、具体的な記載をする。

□最低限、「支持的精神療法」など内容がわかる記載が求められる。

⑥「今後の治療方針」

- 「通院」あるいは「薬物療法、精神療法」

→これは治療方針のうち、方法についてであるが、目標が含まれていない。

□治療の目標とそれへ向けての方法を意識して記載する。

□例)上記の例では、「抗うつ剤を継続しながら、職場での対人関係の改善を相談することにより(方法)、うつの再発を予防する(目標)」など、個別性に配慮した具体的な記載をする。

最後に

- 自立支援医療（精神通院医療）は診断書から状態を読み取って判定するため、診断書に継続した通院が必要な状況が分かる記載がされていることが必要です。
- 最低限、個別性に配慮した診断や治療がなされていることを、読んでいる審査委員が判断できるように、簡潔かつ的確な記載が求められます。
- 発症や治療開始時の所見、その後の経過や症状、特に治療内容と治療方針が個別性に配慮して書かれていることが求められます。
- 自立支援医療には公費が投入されており、適正な制度運用が今後の制度の持続性確保のためには重要になります。制度の趣旨を理解し、適正な診断書の記載をお願いします。